

LA DYSPHAGIE

Plan du cours

- 1/ Objectifs du cours
- 2/ Introduction : -Rappel anatomo-physiologique
- Définition de quelques signes fonctionnels digestifs
- 3/ Définition de la dysphagie
- 4/ Orientation clinique : Anamnèse
Clinique
Explorations
- 5/ Etiologies des dysphagies :
- 6/Conclusion

1/ Objectifs du cours :

Savoir reconnaître une dysphagie et argumenter les principales hypothèses diagnostiques afin de prescrire les examens complémentaires pertinents.

2/Introduction :

a/ Rappel anatomo-physiologique de la déglutition

L'œsophage est un organe tubulaire fermé à ses 2 extrémités (sphincters) :

- Revêtu d'un épithélium Malpighien, de structure musculaire striée et lisse,
- Double innervation extrinsèque (pneumogastriques) et intrinsèque (plexus nerveux autonome) qui permet la propulsion des aliments du pharynx vers l'estomac.

Motricité œsophagienne :

- A l'état de repos, l'œsophage est vide et n'est animé d'aucune contraction. Il est fermé à ses deux extrémités grâce à la contraction tonique de ses 2 sphincters, ce qui protège à la fois les VAS et le bas œsophage d'un reflux du contenu gastrique.
- Au moment de la déglutition, immédiatement après le relâchement du sphincter supérieur de l'œsophage (SSO) « la bouche de Killian » ; une onde péristaltique parcourt l'œsophage de haut en bas. Le SIO (sphincter inférieur de l'œsophage) se relâche avant même que l'onde péristaltique ne l'ait atteint, il reste ouvert pendant toute la durée de la progression de la contraction et du bol alimentaire.

La déglutition comporte un temps volontaire oral et un temps réflexe pharyngo-laryngo-œsophagien.

b/ Définition de quelques signes fonctionnels digestifs:

b-1 : L'Anorexie :

Une diminution ou perte de l'appétit, globale ou élective (dégoût de certains aliments). Elle peut-être secondaire à une infection sévère comme la tuberculose, à des néoplasies, ou être d'origine psychique : anorexie mentale, dans ce contexte la boulimie, comme l'anorexie constitue un trouble du comportement alimentaire (TCA) sans atteinte organique.

b-2 : La Polyphagie : est à l'inverse une augmentation de l'appétit. Exp. au cours du diabète.

b-3 : Le Pyrosis : Sensation de brûlures rétro sternales ascendante de l'estomac vers la bouche (décrit comme un reflux acide). Le reflux dans le larynx ou les bronches est possible.

Il est spontané ou aggravé par les repas gras et la position penchée en avant, parfois nocturne, il sera amélioré par la position surélevé du tronc et témoigne le plus souvent d'un reflux gastro-œsophagien (RGO).

b-4 : La régurgitation : Reflux involontaire vers la bouche, sans effort de vomissements de débris alimentaires contenus dans l'œsophage survenant soit immédiatement après le repas ou plus tard lorsque le patient s'allonge (exp nourrissons).

b-5 : Le mérycisme : ou rumination est un besoin incontrôlable de rappeler dans la bouche des aliments que l'on vient d'avaler et de les déglutir, symptôme rare s'observe dans certaines affections psychiatriques.

b-6 : Hyper-sialorrhée : augmentation du débit salivaire.

b-7 : Eructation : Expulsion bruyante d'air par la bouche ou le nez provenant de l'œsophage ou de l'estomac (rot).

3/Définition de la dysphagie :

- C'est une sensation de gêne à la déglutition ou obstacle à la progression du bol alimentaire entre la bouche et l'estomac, décrite par le patient comme une simple gêne, une difficulté ou un arrêt complet des aliments.
- Ce symptôme traduit une lésion fonctionnelle ou organique au niveau de l'oropharynx, de l'œsophage ou de la partie proximale de l'estomac.
- L'endroit où la sensation de gêne est ressentie ne correspond pas toujours au siège de la lésion (douleur ou gêne projetée).

4/Orientation diagnostique :

Un interrogatoire attentif et un examen clinique soigneux permettent généralement d'orienter le diagnostic.

A - L'interrogatoire :

- *Les antécédents personnels* : orientent le diagnostic
 - Intoxication alcoolique tabagique.
 - Ingestion de caustiques (accidentelle ou volontaire),
 - Corps étrangers
 - Radiothérapie médiastinale, thoracique et cervicale
 - Pathologie œsogastrique connue (hernie hiatale, RGO)
 - Antécédents chirurgicaux et ORL.
 - Maladie systémique (sclérodermie...)
- Doit préciser les caractéristiques de la dysphagie.
 - *La date de début* : * Récente → obstacle organique.
* Ancienne → fonctionnel.
 - *Circonstances de survenue* : aigue, provoquée ou spontanée.
- *Le mode de début* :
 - * Brutal (corps étranger)
 - * Progressif : simple accrochage des aliments puis aggravation de la dysphagie pour les solides : progressif → Cancer.
- *Le degré de dysphagie* : minime, importante ou à l'extrême aphagie.
- *Le siège* : rapporté par le patient ne présume pas toujours du siège exact de la lésion.
 - * Dysphagie haute: le blocage est au niveau de la région hyoïdienne ou sous-hyoïdienne
 - * Dysphagie medio-thoracique : Dysphagie rétro-sternale.
 - * Dysphagie basse : rétro-xiphoidienne ou en regard du creux épigastrique.
- *Le mode d'évolution* : intermittente ou permanente.
- *Type de Dysphagie* :
 - * Sélective (pour certains aliments) ou non sélective (pour tous les aliments).

*Partielle (pour les solides seulement) ou totale (Aphagie solides et liquides).

*Paradoxe (pour les liquides et non pour les solides)

- *Les signes associés :*

* Hyper-sialorrhée, pyrosis, régurgitations, éructation, douleurs œsophagiennes.

* Douleurs thoraciques ou dorsales, fausses routes ++ ou une toux au cours des repas, hoquet, dysphonie, dyspnée...

* Des signes généraux : asthénie, anorexie, amaigrissement +++, fièvre

- *L'âge :* les causes de dysphagie diffèrent si c'est un enfant (troubles primitifs de la motricité) ou un adulte (d'abord éliminer un cancer chez l'adulte).

- *Caractère douloureux :* Odynophagie

Diagnostic différentiel : la dysphagie est à différencier de :

- *Globus hystericus* « boule d'angoisse » : sensation de striction cervicale généralement liée à de l'anxiété.
- L'anorexie (perte d'appétit), surtout lorsqu'elle est élective.

B- L'EXAMEN CLINIQUE :

-Il doit rechercher le retentissement de la dysphagie sur l'état général : Etat nutritionnel poids, pli de dénutrition ou pli cutané de déshydratation

-Il doit être complet : l'examen des aires ganglionnaires cervicales (rechercher une volumineuse adénopathie), l'examen de la loge thyroïdienne, un examen ORL (L'examen à l'abaisse-langue de la cavité buccale et de l'oropharynx : la morphologie du pharynx et du larynx, à la recherche d'une tumeur du pharynx) et un examen neuromusculaire : l'étude des paires crâniennes, la mobilité linguale, vélaire et laryngée.

C/EXPLORATIONS:

Toute dysphagie impose un bilan radio endoscopique +++.

La conduite du bilan dépendra de l'étiologie suspectée d'après l'anamnèse et l'examen clinique :

- **Fibroscopie œso-gastrique** (+ biopsies) : **systématique.**
- **Nasofibroscopie et laryngoscopie**: lors de l'examen ORL ; elle permet de détecter une cause tumorale pharyngée, un trouble neurologique du carrefour pharyngolaryngé (Paralysie du pharynx et/ou du larynx).
- Radiographie pulmonaire : recherche une cause de compression œsophagienne
- Transit baryte œsophagien (moins utilisé actuellement) recherche le diverticule de Zenker
- Manométrie œsophagienne: examen clef pour le diagnostic de la dysphagie fonctionnelle
- PH-métrie: essentielle pour le diagnostic du reflux.
- Tomodensitométrie thoracique, cervicale, abdominale : causes tumorales ou compressives
- écho-endoscopie.

5/LES ETIOLOGIES DES DYSPHAGIES :

A/ OESOPHAGIENNES :

5-A-1/ Causes mécaniques (obstruction) :

1-a/Cancer de l'œsophage et du cardia: Dysphagie récente qui siège au niveau de l'œsophage, d'abord aux solides uniquement puis rapidement progressive avec un amaigrissement important.

1-b /Tumeurs bénignes : rares, léiomyome, adénome.

1-c/Sténose peptique suite à une œsophagite peptique : compliquant un reflux gastro-œsophagien (RGO) : la dysphagie est ancienne, généralement basse, aux solides uniquement, d'aggravation lente, sans amaigrissement, souvent on retrouve des antécédents de pyrosis ou de régurgitation anciens

Les symptômes du RGO traduisent le passage passif du contenu gastrique vers l'œsophage : -
Pyrosis : favorisé par le décubitus après un repas, après un effort ou déclenchée par les changements de position (notamment le décubitus ou l'antéflexion du tronc : signe du lacet (le pyrosis survient lors du lacement des chaussures).

1-d/Endobrachyœsophage: Transformation de la muqueuse malpighienne œsophagienne en une muqueuse glandulaire gastrique ; le risque est la dysplasie et la transformation vers un cancer

1-e/ Diverticule de ZENCKER: hernie de la muqueuse à travers un defect de la musculuse de la paroi pharyngée au dessus du SSO, à la jonction pharyngo-œsophagienne se manifeste par une dysphagie intermittente cervicale associée à des régurgitations d'aliments non digérés

1-f/Corps étrangers : Fréquents chez l'enfant, s'observe chez l'adulte surtout en milieu psychiatrique ou carcéral.

2/ Cause fonctionnelle : Absence d'obstacle mécanique ou organique

a/Mécanismes :

- Réduction de la force de propulsion
- Anomalie de relâchement sphinctérien.

b/Les causes sont :

b-1/Primitives :

***/Achalasie du cardia** ou méga œsophage idiopathique : il s'agit d'un trouble moteur primitif de l'œsophage défini par une absence du péristaltisme du corps de l'œsophage associée à une relaxation du SIO absente ou incomplète lors de la déglutition. Due à une altération de l'innervation intrinsèque de l'œsophage

- Clinique : dysphagie paradoxale, capricieuse - TOGD: dilatation du corps de l'œsophage.
- Diagnostic : repose sur la manométrie +++ : absence d'ondes péristaltiques propagées.

***/Maladie des spasmes étagés** de l'œsophage : douleurs rétro sternales per ou postprandiales intermittentes, il s'agit d'un trouble du péristaltisme avec une bonne relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage lors de la déglutition, c'est la manométrie qui confirme ce trouble.

b-2/Secondaires :

- Les causes neurologiques : paralysie des paires crâniennes, Sclérose latérale amyotrophique
- Les maladies musculaires : Myopathie, Myasthénie....
- Œsophagite infectieuse : mycosique (Candidose), Herpétique ou tuberculeuse (rare).
- Œsophagite post-radique après irradiation pour un cancer bronchique ou du sein.

B/ CAUSES EXTRA-OESOPHAGIENNES:

1/ Causes oro-pharyngées infectieuses : La dysphagie est ressentie comme une difficulté d'initier la déglutition : Angine streptococcique s'accompagne d'une dysphagie douloureuse

Pharyngite,

Candidose bucco-pharyngée.

2/Cancer du pharynx

3/Les causes compressives : pas de lésion in situ mais compression extrinsèque de l'œsophage par les organes de voisinage :

- Tumeur bronchique.
- Adénopathie.
- Cancer volumineux de la thyroïde et les goitres compressifs
- Tumeurs médiastinales.
- Rarement grosse oreillette gauche suite à un rétrécissement Mitral, anévrisme Aortique

6 / Conclusion

La dysphagie est un symptôme digestif sérieux qui nécessite une enquête étiologique rigoureuse pour ne pas retarder le diagnostic de certaines étiologies telles que le cancer de l'œsophage.